

GLUCO OFF® Film Coated Tablets



Composition:

Each GLUCO OFF 2.5 Film Coated Tablet contains: Metformin Hydrochloride 500 mg and Glyburide 2.5 mg.

Each GLUCO OFF 5 Film Coated Tablet contains:

Metformin Hydrochloride 500 mg and Glyburide 5 mg.

Mechanism of Action:

GLUCO OFF combines Glyburide and Metformin Hydrochloride, two antihyperglycemic agents with complementary mechanisms of action, to improve glycemic control in patients with type 2 diabetes. Glyburide appears to lower blood glucose acutely by stimulating the release of insulin from the pancreas.

Metformin works by decreasing hepatic glucose production, decreasing intestinal absorption of glucose, and improving insulin sensitivity.

Pharmacokinetics:

After an oral dose of GLUCO OFF, maximum plasma concentration (C_{max}) is reached in 2.5 hours (t_{max}). Metformin absorption is saturable and incomplete. Plasma protein binding is negligible. Metformin is excreted unchanged in the urine. The elimination half-life is approximately 6.5 hours.

Single-dose studies Glyburide demonstrate significant absorption of Glyburide within 1-hour, peak drug levels at about 4 hours. Glyburide is extensively bound to serum proteins. Glyburide is excreted as metabolites in the bile and urine, approximately 50% by each route. The terminal half-life is about 10 hours.

Indications:

GLUCO OFF is indicated for the management of type II diabetes mellitus when diet, exercise and single drug therapy do not result in adequate glycemic control.

Contraindications:

- Hypersensitivity to the active substances or to any of the Excipients.
- Acute or chronic metabolic acidosis, including diabetic ketoacidosis, with or without coma.
- Type 1 diabetes (insulin-dependent diabetes).
- Severe renal failure (GFR <30 mL/min).
- Acute conditions that can affect kidney function such as: dehydration and shock.
- Concomitant administration of bosentan.
- Alcoholism (acute, chronic).

Warnings & Precautions:

- Rare lactic acidosis may occur due to Metformin accumulation.
- The administration of oral hypoglycemic drugs has been reported to be associated with increased cardiovascular mortality as compared to treatment with diet / diet plus insulin.
- GLUCO OFF contains a sulphonylurea (Glyburide), it exposes the patient to a risk of onset of hypoglycaemic episodes.

Pregnancy & Lactations:

Pregnancy: GLUCO OFF must not be taken during pregnancy. The patient must change over to insulin during pregnancy.
Lactation: In view of the risk of neonatal hypoglycaemia, GLUCO OFF is contraindicated in the event of breast-feeding.

Driving & Using Machines:

Patients should be alerted to the symptoms of hypoglycaemia and should be advised to exercise caution when driving or using machines.

Drug Interactions:

Bosentan: Increased liver enzymes.

Inducers or inhibitors of CYP 2C9: Glyburide is mainly metabolized by CYP 2C9.

Cyclosporine: Glyburide may increase cyclosporine plasma

concentration and potentially lead to its increased toxicity.

Insulin and other, oral antidiabetics: Increased risk of hypoglycaemia.

Alcohol: Alcohol intoxication is associated with an increased risk of lactic acidosis.

Corticosteroids, beta2-stimulators and diuretics, owing hyperglycemic activity: More frequent blood glucose monitoring may be required. If necessary, adjust the Metformin dosage.

Inhibitors of OCT1 (such as Verapamil) may reduce efficacy of Metformin.

Inducers of OCT1 (such as Rifampicin) may increase absorption and efficacy of Metformin.

Inhibitors of OCT2 (such as Cimetidine, Trimethoprim, Isavuconazole) may decrease the renal elimination of Metformin and thus lead to an increase in Metformin plasma concentration.

Side Effects:

The most noticeable side effects were hypoglycaemia, headache, fullness, nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, loss of appetite and taste disturbance.

Very rare: Lactic acidosis, hemolytic anemia, thrombopenia, agranulocytosis, decrease of vitamin B12 absorption, erythema, urticaria and hepatitis.

Dosage & Administration:

Adults: Initial dose: One GLUCO OFF 2.5 tablet should be administered as once daily with meals. After several days the dose should be adjusted based on blood glucose measurements. For once daily administration maximum 2 tablets of GLUCO OFF 5 can be given. For higher doses it may be necessary to divide the administration into 2 doses. Up to 4 tablets of GLUCO OFF 5 can be given per day.

Renal impairment: Depending on the glomerular clearance rate, the dose is as follows:

Glyburide (Maximum daily)	Metformin (Maximum daily)	GFR (mL/ min)
20 mg (higher daily doses of 20 mg are not recommended because they are more effective only in exceptional cases)	3000 mg Dose reduction may be considered in relation to declining renal function	60- 89
	2000 mg The starting dose is at most half of the maximum dose.	45- 59
	1000 mg The starting dose is at most half of the maximum dose.	30- 44
GLUCO OFF is contraindicated		<30

Geriatric population: Patients aged 65 years and older: starting and maintenance doses of Glyburide must be carefully adjusted to reduce the risk of hypoglycaemia.

Overdose: Overdose may precipitate hypoglycaemia due to the presence of the sulphonylurea. High overdose of Metformin or concomitant risks may lead to lactic acidosis. Lactic acidosis is a medical emergency and must be treated in hospital. The most effective method to remove lactate and Metformin is haemodialysis. Since Glyburide is extensively bound to proteins, it is not eliminated by dialysis.

Storage: Keep out of reach of children.

Store at a temperature below 25°C.

Packaging: GLUCO OFF (2.5-5) Carton Box contains 20 or 30 Film Coated Tablets in two or three blisters.

- A medication is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.
- The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICATIONS OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministries - Union of Arab Pharmacies

Reva Pharmaceutical Industry - Syria



غلوكو أوف

مضغوطات مليسة بالغليم

التركيب:

كل مضغوظة غلوكو أوف ٢,٥ مليسة بالغليم تحتوي على:
ميتورمين هيدروكلوريد ٥٠٠ ملغ و غليبيريد ٢,٥ ملغ.
كل مضغوظة غلوكو أوف ٥ مليسة بالغليم تحتوي على:
ميتورمين هيدروكلوريد ٥٠٠ ملغ و غليبيريد ٥ ملغ.
آلية التأثير:

يجمع غلوكو أوف بين مادتي ميتورمين و غليبيريد، وهما دوائين يُستعملان لمعالجة ارتفاع سكر الدم ويعملان بشكل متكامل، بهدف تحسين التحكم بسكر الدم لدى مرضى الداء السكري من النمط الثاني. يُفترض أن الغليبيريد يخفض نسبة الغلوكون في الدم بشكل حاد عن طريق تحفيز إفراز الأنسولين من البنكرياس. يعمل الميتورمين عن طريق تقليل إنتاج الغلوكون في الكبد وتقليل امتصاصه من الأمعاء وتحسين الإستجابة للأنسولين (حساسية الأنسولين).

الحراك الدوائي:

بعد تناول مضغوظات غلوكو أوف، يتم الوصول إلى أقصى تركيز للميتورمين في البلازما خلال ٢,٥ ساعة. إن امتصاص الميتورمين قابل للإسراع وغير مكتمل. يرتبط بروتينات البلازما بنسبة لا تكاد تذكر. يتم إخراج الميتورمين في البول دون تغيير، حيث يبلغ العمر الصافي للإخراج حوالي ٦,٥ ساعة.

وفقاً لدراسات الجرعة الواحدة يحدث امتصاص الغليبيريد بشكل كبير خلال ساعة واحدة ويبدأ بإعطائه فورياً، ويصل إلى مستوى الذروة خلال حوالي ٤ ساعات. يرتبط الغليبيريد بشكل كبير بروتينات المصل، يُطرح الغليبيريد كمستقلبات في الصفراء والبول، حوالي ٥٠٪ في كل طريق. يبلغ العمر الصافي للإخراج حوالي ١٠ ساعات.

الاستقطابات:

يستطع غلوكو أوف لمعالجة الداء السكري من النمط الثاني عندما لا يؤدي النظام الغذائي والممارين الرياضية والعلاج الدوائي الفردي إلى ضبط نسبة السكر في الدم بشكل كافي.

مضادات الاستقطاب:

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو لأي من مكونات المستحضر.
- الحمض الاستقلابي الحاد أو المزمن، بما في ذلك الحمض الكيتوني السكري، مع أو بدون غيبوبة.
- الداء السكري من النمط الأول (السكري المعتمد على الأنسولين).
- الفشل الكلوي الحاد (معدل التصفية الكلوية أقل من ٣٠ مل/د).
- الحالات الحادة التي يمكن أن تؤثر على وظائف الكلى مثل: الجفاف والصدمة.
- المعالجة باليوسنتان.
- الإدمان على الكحول (الحاد والمزمن).

التحذيرات والاحتياطات:

- في حالات نادرة قد يتطور إلى حمض لبنى بسبب تراكم الميتورمين.
- تم الإبلاغ عن ارتباط استعمال أدوية المضادة لارتفاع سكر الدم الفموية بزيادة معدل وفيات القلب والأوعية الدموية مقارنة بالعلاج بالحمية الغذائية / الحمية الغذائية بالإضافة إلى الأنسولين.
- يحتوي غلوكو أوف على سلفونيل يوريا (غليبيريد)، مما قد يعرض المريض لخطر الإصابة بنوبات انخفاض سكر الدم.

الحمل والإرضاع:

الحمل: يجب عدم استعمال غلوكو أوف خلال فترة الحمل حيث يجب الإنتقال إلى المعالجة باستعمال الأنسولين.

الإرضاع: نظراً لخطر الإصابة بانخفاض سكر الدم عند الأطفال حديثي الولادة، يمنع استعمال غلوكو أوف في حالة الرضاعة الطبيعية.

القيادة واستخدام الآلات:

يجب تنبيه المرضى إلى الأعراض المرافقة لانخفاض سكر الدم ويجب تصحيحه بتوخي الحذر عند القيادة أو استخدام الآلات.

التداخلات الدوائية:

اليوسنتان: ارتفاع أنزيمات الكبد.
محرضات أو مثبطات إنزيمات سيتوكروم 2C9: يتم استقلاب غليبيريد بشكل أساسي بواسطة هذه الجملعة الأنزيمية.
السيكلوسبورين: قد يزيد غليبيريد من تركيز السيكلوسبورين في البلازما ومن المحتمل أن يؤدي إلى زيادة سُميته.

الأنسولين وخافضات السكر الفموية الأخرى: ارتفاع خطر الإصابة بانخفاض سكر الدم.

الكحول: ترتبط التسمم بالكحول بزيادة خطر الإصابة بالحمض اللبني. **الستيرويدات القشرية ومقدرات بيتا 2 والمدرات البولية:** بسبب رفعها لمستويات السكر في الدم قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من مراقبة مستويات غلوكو أوف بشكل متكرر. إذا لزم الأمر، فيجب ضبط جرعة الميتورمين.

قد تقلل مضطبات ناقل الشوارد ١ (مثل قير إميلين) من فعالية الميتورمين.
قد تزيد مضطبات ناقل الشوارد ١ (مثل ريفامبيسين) من امتصاص وفعالية الميتورمين.

قد تقلل مضطبات ناقل الشوارد ٢ (مثل سيميبتين، تريميثوبريم، إيزوفلوكلزول) من الإطراح الكلوي من الميتورمين وبالتالي تؤدي إلى زيادة تركيز الميتورمين في البلازما.

التأثيرات الجانبية:

الأثار الجانبية الأكثر ملاحظة هي: هبوط سكر الدم، الصداع، النفخة، الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن وفقدان الشهية واضطراب التنوؤ. كما أن هناك تأثيرات نادرة جداً مثل: الحمض اللبني، فقر الدم الانحلالي، قلة الصفائح، قلة الدمحبات، نقص امتصاص فيتامين ب١٢، حمامي، شرى والتهاب الكبد.

الجرعة والاستعمال:

البالغين: جرعة البدء مضغوظة واحدة من غلوكو أوف ٢,٥ يتم تناولها مرة واحدة يومياً وتؤخذ مع الطعام. بعد عدة أيام، يجب تعديل الجرعة بناءً على قياسات سكر الدم. يمكن إعطاء قرصين كحد أقصى من غلوكو أوف ٥ مرة واحدة يومياً. بالنسبة للجرعات العالية، قد يكون من الضروري تقسيم الجرعات على دفعتين. يمكن إعطاء ما يصل إلى ٤ أقراص من غلوكو أوف ٥ يومياً.

في حالة القصور الكلوي:

يتم ضبط الجرعة وفقاً لمعدل التصفية الكلوية (GFR)، وتكون الجرعة وفقاً للتالي:

معدل التصفية الكلوية (مل/د)	ميتورمين (الجرعة اليومية الفموية)	غليبيريد (الجرعة اليومية الفموية)
٨٩-٦٠	٣٠٠٠ ملغ يمكن تناوله في ٢ مضغوظة واحدة مع الطعام	٢٠ ملغ (لا ينصح بجرعات يومية أعلى من ٢٠ ملغ لأنها أكثر فعالية فقط في حالات استثنائية)
٥٩-٤٥	٢٠٠٠ ملغ جرعة البدء يجب أن تكون نصف الجرعة الفموية	
٤٤-٣٠	١٠٠٠ ملغ جرعة البدء يجب أن تكون نصف الجرعة الفموية	
أقل من ٣٠	غلوكو أوف مضاد استقطاب في هذه الحالة	

كبار السن: المرضى الذين تبلغ أعمارهم ٦٥ عاماً أو أكثر: يجب تعديل جرعات البدء وجرعات المداومة من غليبيريد بعناية لتقليل مخاطر نقص السكر في الدم.

فرط الجرعة: قد تؤدي الجرعة الزائدة من غلوكو أوف إلى حدوث نقص السكر في الدم بسبب إحتوائه على السلفونيل يوريا. كما تؤدي الجرعات الزائدة من الميتورمين إلى المخاطر الصحية لها إلى الإصابة بالحمض اللبني.

يُعد الحمض اللبني حالة طبية طارئة ويجب معالجتها في المستشفى. الطريقة الأكثر فعالية لإزالة اللاكتات من الميتورمين هي إجراء الغسيل الكلوي. نظراً لأن الغليبيريد يرتبط إلى حد كبير بالبروتينات، فلا يتم التخلص منه عن طريق الغسيل الكلوي.

شروط الحفظ: يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. يُحفظ في درجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية.

التعبئة: كل عبوة كرتونية غلوكو أوف (٥, ٢,٥) تحتوي على ٢٠ أو ٣٠ مضغوظة مليسة بالغليم ضمن شريطين أو ثلاثة أشرطة بليستر.

الدواء مستحضر بولي عرصة، مستحضر، راسب، خلاصاً للتعبئة بحسب الطلب.
أنتج بواسطة الصيدلة ريفيا للاستعمال المخصص عليها وتحت إشراف الصيدلاني أنتج صرفها في ك، الطب، والصيدلانيات في العراق أو في العراق وبقية وخرور
أكثر من صرف الدواء بدون وصفة طبية
توفر الأثرية مثل: في الأطفال
مجلس وزراء الصحة العرب، ريفيا للصناعات الدوائية - سوريا
إنتاج شركة ريفيا للصناعات الدوائية - سوريا